

Síntomas positivos, negativos y desorganizados

1. Introducción y relevancia clínica

La esquizofrenia es un trastorno mental crónico, grave y multifactorial, caracterizado por una alteración profunda del pensamiento, la percepción, el afecto y la conducta, con pérdida del contacto con la realidad.

Su prevalencia global es del 1% de la población, con inicio típico entre los 15 y 30 años, afectando ligeramente más a hombres (inicio más precoz).

Es una de las principales causas de discapacidad psiquiátrica, con gran impacto familiar y social.

El diagnóstico se basa en la presencia de síntomas psicóticos durante al menos 6 meses, con afectación significativa del funcionamiento social o laboral.

Estos síntomas se agrupan en tres grandes categorías:

- Positivos: exceso o distorsión de funciones normales.
- Negativos: disminución o pérdida de funciones normales.
- Desorganizados: alteración del pensamiento, lenguaje o conducta.

□ En el EUNACOM, las preguntas más frecuentes sobre este tema incluyen:

- Diferencia entre síntomas positivos, negativos y desorganizados.
 - Fisiopatología dopaminérgica (hiperactividad vs hipoactividad).
 - Respuesta diferencial a antipsicóticos típicos y atípicos.
 - Identificación de fases clínicas de la esquizofrenia.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La esquizofrenia es un trastorno neurobiológico con vulnerabilidad genética y disfunción de neurotransmisores, en especial dopamina, glutamato y serotonina.

2.1. Hipótesis dopaminérgica clásica

- **Hiperactividad dopaminérgica mesolímbica → síntomas positivos (alucinaciones, delirios).**
- **Hipoactividad dopaminérgica mesocortical → síntomas negativos y cognitivos.**
- **Vías nigroestriadas: implicadas en efectos extrapiramidales de antipsicóticos típicos.**
- **Vías tuberoinfundibulares: su bloqueo produce hiperprolactinemia.**

□ **Esta hipótesis explica por qué los antipsicóticos dopaminérgicos (bloqueadores D₂) reducen los síntomas positivos, pero pueden empeorar los negativos.**

2.2. Hipótesis glutamatérgica

- **Disminución de la actividad del receptor NMDA → desinhibición de la liberación dopaminérgica mesolímbica y déficit cortical.**
 - **Esto explica los síntomas cognitivos y desorganizados, y por qué los antagonistas NMDA (como fenciclidina o ketamina) inducen síntomas psicóticos similares.**
-

2.3. Alteraciones estructurales cerebrales

- **Reducción del volumen cortical y del hipocampo.**
- **Aumento del tamaño ventricular.**
- **Disminución de la conectividad frontotemporal.**

Estos hallazgos sugieren un trastorno del neurodesarrollo más que una lesión adquirida.

2.4. Factores de riesgo

- **Antecedentes familiares de esquizofrenia (riesgo 10% en hijos, 40% si ambos padres).**
- **Complicaciones perinatales, hipoxia, infecciones virales in útero.**

- Consumo de cannabis precoz.
 - Estrés psicosocial intenso o trauma infantil.
 - Edad paterna avanzada.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

La esquizofrenia se caracteriza por una mezcla variable de síntomas positivos, negativos y desorganizados, que pueden presentarse en distintas fases evolutivas.

3.1. Síntomas positivos

Son manifestaciones productivas o excesivas del funcionamiento mental normal.

Tipo	Ejemplo clínico
Delirios	Creencias falsas, fijas, no corregibles por la lógica o evidencia. Ej: “Me siguen los servicios secretos”.
Alucinaciones	Percepciones sin estímulo externo (principalmente auditivas: voces que comentan o dan órdenes).
Ideas de referencia	Interpretación errónea de estímulos neutros (“la TV me envía mensajes”).
Pensamiento mágico o persecutorio	Creencia de poseer poderes especiales o ser controlado.

Estos síntomas suelen ser los más llamativos y motivan la hospitalización.

3.2. Síntomas negativos

Reflejan una pérdida o disminución de funciones normales, y son más persistentes y resistentes al tratamiento.

Síntoma	Descripción
Aplanamiento afectivo	Pobreza de expresión emocional, rostro inexpresivo.
Alogia	Disminución del flujo verbal o pobreza de contenido del habla.
Abulia / avolición	Falta de motivación o energía para realizar actividades.
Anhedonia	Incapacidad para experimentar placer.
Asocialidad	Aislamiento, escaso interés en relaciones personales.
☐ Son los principales responsables del deterioro funcional y social del paciente esquizofrénico.	

3.3. Síntomas desorganizados

Alteraciones en el pensamiento, lenguaje y comportamiento.

Componente	Ejemplo
Lenguaje desorganizado	Incoherencias, tangencialidad, neologismos, fuga de ideas.
Conducta desorganizada o catatónica	Actos bizarros, agitación sin propósito, negativismo, manierismos o mutismo.

Pensamiento ilógico o fragmentado

Incapacidad de mantener una línea argumental.

3.4. Fases clínicas

- 1. Prodrómica: aislamiento social, irritabilidad, disminución del rendimiento, síntomas negativos incipientes.**
- 2. Activa o florid: predominan síntomas positivos (delirios, alucinaciones).**
- 3. Residual: persistencia de síntomas negativos tras control psicótico.**

3.5. Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferenciación clave
Trastorno esquizoafectivo	Episodios afectivos mayores (depresión/manía) presentes junto a síntomas psicóticos.
Trastorno esquizofreniforme	Igual clínica pero duración entre 1–6 meses.
Trastorno delirante persistente	Delirio no bizarro sin alteraciones del pensamiento o conducta.
Psicosis inducida por sustancias	Historia clara de consumo y remisión al suspenderla.
Trastorno bipolar con síntomas psicóticos	Psicosis circunscrita a episodios afectivos.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. DSM-5 (Esquizofrenia)

Se requieren ≥ 2 de los siguientes (1 debe ser A, B o C):

A. Delirios.

B. Alucinaciones.

C. Discurso desorganizado.

D. Conducta marcadamente desorganizada o catatónica.

E. Síntomas negativos.

Además:

- Duración ≥ 6 meses (incluyendo 1 mes de síntomas activos).
 - Disfunción social o laboral significativa.
 - No atribuible a sustancias o enfermedad médica.
-

4.2. Exámenes complementarios

- Laboratorio general: hemograma, glicemia, perfil hepático, TSH.
 - Exclusión orgánica: neuroimagen (TC/RMN), test de drogas, VDRL, VIH, B12.
 - Evaluación cognitiva: mini-mental o batería neuropsicológica.
-

5. Tratamiento (según Guías MINSAL y consenso internacional)

El tratamiento de la esquizofrenia es multidimensional, combinando farmacoterapia antipsicótica, psicoterapia, rehabilitación psicosocial y educación familiar.

5.1. Fase aguda (control psicótico)

Objetivo: reducir síntomas positivos y estabilizar al paciente.

Antipsicóticos de primera línea (atípicos o de segunda generación):

- Risperidona 2–6 mg/día
- Olanzapina 10–20 mg/día
- Quetiapina 300–600 mg/día
- Aripiprazol 10–30 mg/día
- Ziprasidona 80–160 mg/día

☐ Elegidos por su menor riesgo extrapiramidal y mayor eficacia sobre síntomas negativos y afectivos.

Antipsicóticos típicos (primera generación):

- Haloperidol 5–15 mg/día → útil en crisis aguda con agitación.
- Efectos adversos: rigidez, distonía, acatisia, discinesia tardía.

5.2. Fase de mantenimiento

- Continuar el antipsicótico por al menos 12–24 meses tras el primer episodio.
- En casos de recaídas múltiples: tratamiento indefinido.
- Dosis mínimas efectivas y buena adherencia.
- Formas depot (inyectables de larga duración) mejoran cumplimiento (palmitato de risperidona, aripiprazol LAI).

5.3. Esquizofrenia resistente

Definida como falta de respuesta a ≥ 2 antipsicóticos durante ≥ 6 semanas a dosis adecuadas.

☐ Tratamiento de elección: Clozapina (100–900 mg/día).

- Eficaz sobre síntomas positivos y suicidios.
 - Requiere control de neutrófilos (riesgo de agranulocitosis).
-

5.4. Psicoterapia y rehabilitación

- Psicoeducación familiar: reduce recaídas.
 - Terapia cognitivo-conductual para psicosis (TCC-p): mejora insight y adherencia.
 - Rehabilitación psicosocial: inserción laboral, manejo de autocuidado y habilidades sociales.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- Depresión postpsicótica.
- Conductas suicidas (riesgo hasta 10%).
- Abuso de sustancias.
- Aislamiento social, desempleo, pobreza.
- Síndromes extrapiramidales (por fármacos).
- Síndrome metabólico (por antipsicóticos atípicos).

Pronóstico

- 20% recuperación completa, 50% funcional parcial, 30% curso crónico.
- Mejor pronóstico: inicio agudo, buen insight, apoyo familiar, predominio de síntomas positivos.
- Peor pronóstico: inicio insidioso, síntomas negativos marcados, sexo masculino, antecedentes familiares.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. Síntomas positivos: exceso (delirios, alucinaciones).
2. Síntomas negativos: déficit (abulia, anhedonia, aplanamiento).
3. Desorganizados: pensamiento y conducta incoherente.
4. ISRS NO sirven para síntomas psicóticos.
5. Clozapina es el fármaco de elección en esquizofrenia resistente.
6. Insight preservado → psicosis breve o afectiva, no esquizofrenia.
7. Los antipsicóticos atípicos mejoran síntomas negativos y tienen menor riesgo extrapiramidal.



Errores comunes

- Diagnosticar esquizofrenia sin descartar psicosis por sustancias.
- Suspender tratamiento tras el primer episodio.
- Usar benzodiacepinas como terapia principal.
- No monitorizar efectos metabólicos de atípicos (peso, glicemia, lípidos).
- Ignorar la importancia de la psicoeducación familiar.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

- 1. La esquizofrenia se caracteriza por síntomas positivos, negativos y desorganizados.**
- 2. Hiperactividad dopaminérgica mesolímbica → síntomas positivos; hipoactividad mesocortical → negativos.**
- 3. Antipsicóticos atípicos son de primera línea; clozapina en resistencia.**
- 4. El tratamiento debe mantenerse mínimo 1–2 años tras el primer episodio.**
- 5. La TCC y psicoeducación familiar mejoran el pronóstico.**
- 6. Efectos metabólicos de los atípicos deben controlarse regularmente.**
- 7. Pronóstico funcional depende del predominio de síntomas negativos y adherencia terapéutica.**